

· 研究荟萃 ·

医护一体化模式在老年痴呆症患者中的应用

周荣梅 葛兆霞 张智

210008 南京, 南京大学医学院附属鼓楼医院老年科门诊(周荣梅), 老年科(葛兆霞、张智)

通信作者: 葛兆霞, Email: 1850208752@qq.com

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2017.30.010

【摘要】目的 分析医护一体化模式对老年痴呆症住院患者认知功能、活动能力的影响, 以及在护理中的风险预防效果, 为今后提高老年痴呆症住院患者护理质量提供参考。方法 选择 100 例老年痴呆症住院患者作为研究对象, 按照随机数字表法将其分为两组, 各 50 例。对照组实施常规护理, 观察组实施医护一体化护理, 采用活动能力量表(ADL)、简易智能量表(MMSE)、认知功能评分评估两组患者干预后康复情况, 调查患者家属对护理的满意度, 记录患者不良事件发生情况。结果 观察组不良事件发生率(4.00%)低于对照组(18.00%), 差异具有统计学意义($\chi^2=5.00, P=0.02$), 且家属护理总满意度(92.0%)高于对照组(76.0%), 差异具有统计学意义($\chi^2=8.37, P<0.01$)。结论 医护一体化护理可以有效控制不良事件风险, 促进患者认知功能、活动能力改善, 提高护理满意度。

【关键词】痴呆; 康复; 医护一体化; 不良事件

基金项目: 江苏省卫生计生委科研课题(320.71); 2015 年江苏省干部保健科研课题(BJ15008)

Application of doctor-nurse integration model in elderly patients with dementia Zhou Rongmei, Ge Zhaoxia, Zhang Zhi

Geriatrics Clinic, Nanjing Drum Tower Hospital, the Affiliated Hospital of Nanjing University Medical School, Nanjing 210008, China (Zhou RM); Geriatrics Department, Nanjing Drum Tower Hospital, the Affiliated Hospital of Nanjing University Medical School, Nanjing 210008, China (Ge ZX, Zhang Z)

Corresponding author: Ge Zhaoxia, Email: 1850208752@qq.com

【Abstract】Objective To explore the effects of doctor-nurse integration model on cognitive function and activity ability as well as risk prevention in nursing so as to provide a reference for improving quality of nursing among elderly inpatients with dementia. Methods A total of 100 elderly inpatients with dementia were recruited as study subjects. They were divided into control group ($n=50$, conventional nursing) and observation group ($n=50$, nursing based on doctor-nurse integration model) by random number table. The rehabilitation of patients of both groups after intervention was evaluated with the activities of daily living (ADL), mini-mental status examination (MMSE) and the scale of elderly cognitive function. Besides, this study also investigated the degree of satisfaction of family members with nursing care and recorded the occurrence of adverse events. Results The incidence of adverse events in the observation group (4.00%) was lower than that in the control group (18.00%) with a significant difference ($\chi^2=5.00, P=0.02$). The satisfaction of family members with nursing care was 92.0% in the observation group significantly higher than 76.0% in the control group ($\chi^2=8.37, P<0.01$). Conclusions The doctor-nurse integration model can effectively control the risk of adverse events and improve the cognitive function and activity ability of patients as well as degree of satisfaction with nursing care.

【Key words】Dementia; Rehabilitation; Doctor-nurse integration model; Adverse event

Fund programs: Research Program of Jiangsu Provincial Commission of Health and Family Plan (320.71); Research Program of Jiangsu Provincial Cadre Health Care in 2015 (BJ15008)

老年痴呆症多发生于年龄 ≥ 60 岁的老年人群中, 持续时间久, 损害患者认知功能, 导致患者定向力、语言、思维、计算、记忆能力下降, 出现人格改变和情感障碍, 并伴有自身生活能力和社会活动能力减退现象, 对患者健康构成严重威胁。近年来随着老龄化加重, 发病率出现上升趋势, 成为全社会关注的健康问题。然而老年痴呆症患者病情特殊, 住

院期间安全隐患较多, 常规护理以患者病情为服务主体, 很难为其提供全面的护理, 因此效果并不理想^[1]。近年来医护一体化护理模式逐渐兴起, 应用于骨科、神经科、妇产科等许多科室, 能显著减少风险事件, 提高患者生活质量。为减少护理风险事件, 改善患者认知功能, 笔者将医护一体化模式应用于住院老年痴呆症患者的干预, 现报道如下。

一、资料与方法

1. 一般资料: 2015 年 8 月—2016 年 8 月, 笔者收集 100 例老年痴呆症患者。纳入标准: (1) 符合 WHO 制定的 DSM-IV 诊断标准^[2]; (2) 年龄 60~75 岁; (3) 患者及其家属知情且签署同意书。排除标准: (1) 严重肝、肾、心、脑等重要器官疾病及恶性肿瘤患者; (2) 临床治疗不完整。按照随机数字表法将其分为两组, 各 50 例; 其中观察组: 男 23 例, 女 27 例; 年龄 61~68 岁, 平均(64.7±1.8) 岁; 文化程度, 小学 12 例, 初中 26 例, 高中及以上 12 例, 均实施医护一体化护理。对照组: 男 25 例, 女 25 例; 年龄 60~69 岁, 平均(65.2±1.9) 岁; 文化程度, 小学 10 例, 初中 27 例, 高中及以上 13 例, 均实施常规护理。两组患者基线资料比较差异无统计学意义(P 值分别为 0.160、0.180、0.887)。所有患者均知情同意并签署同意书, 研究通过医院伦理委员会批准。

2. 方法: 将两组患者分别安排于不同老年科病区。(1) 对照组: 行常规护理。包括协助或监督患者进食、如厕、自我清洁; 适当安慰无法独立完成基本生活活动的患者, 调节其情绪; 确保室内安静、光线柔和, 促进患者睡眠, 并保证充足的睡眠时间; 观察患者病情变化, 鼓励患者适当参加集体活动等; 护士、医生各自进行查房。(2) 观察组: 行医护一体化护理。①查房优化。医护人员联合查房; 交接班前 15 min, 值班医生、护士和护理组长一同查房 1 次, 核对晨间医嘱执行情况 and 护理情况; 早上进行大交接班, 护士长和科主任点评前夜护理质量, 交接班后护士长和科主任带领医护人员查看危重患、新入院患者、特殊处理患者治疗和护理措施, 及时评价; 下午由护士长和科主任联合查房及时发现问题并解决; 晚间 22:00 由夜班护士和值班医生联合查房, 及时处理安全隐患; 每周一上午进行大交接班, 护士长及科主任带领小组组长及医生查房, 主管医生报道治疗方案及病史, 责任护士报告患者睡眠、饮食、体征情况, 护士长对其护理进行指导, 对护理中不足制定相应护理补救方案^[3]。②加强基础护理。患者入院后, 责任护士使用日常生活能力(activities of daily living, ADL)量表准确评估患者活动能力, 医生及护士长根据患者 ADL 量表得分开出护理级别医嘱和护理注意事项; 责任护士强化基础护理, 督促患者进行梳洗、穿衣、进食、大小便等生活自理能力训练, 协助患者翻身, 及时按摩受压部位, 提供干净整洁的床单等预防压疮等并发症, 医护人员查房时, 医生评估患者潜在并发症风险并指导护理。③风险管理。结合本院跌倒、压疮、噎食等不良事件发生情况, 制

订针对性风险干预方案, 根据风险程度制定评估方案。患者入院后除接受常规检查, 还需接受风险评估, 以确定是否存在噎食、跌倒、压疮等风险, 并将风险分为高度、中度和轻度, 责任护士每周对患者评估 1 次风险。④人文关怀护理。包括为患者庆生, 邀请病友、家属等一同参加; 传统节日邀请大学生志愿者表演, 并鼓励患者加入其中, 进行互动; 根据患者喜好下载治疗性音乐, 缓解其负面情绪。

3. 观察指标: 对比两组患者干预前后 ADL^[4]、简易智能量表(mini-mental status examination, MMSE)^[5]、认知功能量表分值。(1)ADL 量表: 包括工具性活动力量表(包括做家务、打电话等 8 项)、躯体生活自理 2 个量表(包括洗澡、行走、如厕等 6 项), 最高 64 分, 分值越高则功能障碍越明显。(2)MMSE 量表: 包括定向力、记忆力、注意力和计算力、回忆和语言能力 5 个方向、30 个项目, 每项回答正确计 1 分, 回答错误或不知道计 0 分, 量表总分为 0~30 分; 测验成绩与文化程度密切相关, 平均耗时约 10 min。根据 MMSE 量表划定不同文化教育程度人群的划界分: 文盲 ≤ 17 分、小学 ≤ 20 分、中学及以上 ≤ 24 分为痴呆。(3)认知功能量表: 包括记忆、语言和智力测试。发放问卷调查患者家属对护理的满意度, 100 分制, ≥ 80 分为非常满意, 70~79 分为满意, ≤ 69 分为不满意。(4)不良事件: 记录护理过程中患者出现压疮、跌倒和噎食等不良事件的发生情况, 其中压疮风险采用 Braden 压疮风险护理单, 跌倒和噎食风险采用《临床护理文书书写规范》中提供的跌倒护理单和吞咽进食护理单进行评估; 评估由责任护士每周评估 1 次, 长期护理的患者入院时开始评估, 此后前 4 周每周评估 1 次, 之后每月评估 1 次以及患者病情发生变化时评估。3 组量表的重测信度、评价者之间的信度以及不同评价方法之间的信度 k 值均在 0.511~0.874。

4. 统计学方法: 采用统计学软件 SPSS 18.0 分析数据, 计量资料用均数 ± 标准差($\bar{x} \pm s$)表示, 比较采用独立样本 t 检验; 计数资料用百分率(%)表示, 比较采用 χ^2 检验。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

二、结果

1. 两组患者干预前后活动能力及认知功能比较: 见表 1。两组患者干预前 ADL 及 MMSE 分值比较, 差异不具有统计学意义($P > 0.05$); 观察组患者干预后 ADL 评分低于对照组、MMSE 分值高于对照组, 差异具有统计学意义($P < 0.05$)。

2. 干预前后两组患者认知功能比较: 见表 2。两组患者干预前语言能力、智力水平、记忆能力分值与对照组相比,

表 1 两组老年痴呆症患者干预前后 ADL 及 MMSE 评分比较(分, $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	ADL		MMSE	
		干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	50	35.20 ± 3.12	26.11 ± 3.32	14.28 ± 1.82	16.32 ± 2.19
对照组	50	34.30 ± 2.98	31.33 ± 3.49	14.36 ± 1.77	14.98 ± 1.92
t 值		1.48	7.66	0.22	3.25
P 值		0.14	< 0.01	0.82	< 0.01

表 2 两组老年痴呆症患者认知功能比较(分, $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	记忆能力		智力水平		语言能力	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	50	1.26 ± 1.35	2.99 ± 3.34	4.67 ± 1.69	6.10 ± 1.32	3.12 ± 1.25	4.72 ± 2.87
对照组	50	1.45 ± 1.46	1.47 ± 2.10	4.78 ± 1.86	4.87 ± 1.82	3.07 ± 1.18	3.32 ± 1.87
<i>t</i> 值		0.68	2.71	0.31	3.87	0.58	2.89
<i>P</i> 值		0.50	< 0.01	0.76	< 0.01	0.57	< 0.01

差异不具有统计学意义($P > 0.05$); 观察组干预后上述各项分值均高于干预前, 且高于对照组, 差异具有统计学意义($P < 0.05$)。

3. 两组患者不良事件发生情况比较: 观察组患者压疮、噎食、跌倒发生例数分别为 1、1、0 例, 发生率为 4.00%(2/50), 对照组分别为 5、3、1 例, 发生率为 18.00%(9/50), 两组比较, 差异具有统计学意义($\chi^2=5.005, P < 0.025$)。

4. 两组患者护理满意度比较: 见表 3。观察组患者护理总满意度高于对照组, 差异具有统计学意义($P < 0.05$)。

表 3 两组老年痴呆症患者家属护理总满意度比较(例)

组别	例数	非常满意	满意	不满意	总满意度(%)
观察组	50	14	32	4	92.0
对照组	50	12	26	12	76.0

注: 总满意度比较 $\chi^2=8.37, P < 0.01$

讨论 提高院内老年痴呆症护理的必要性分析: 老年痴呆症是多种因素导致的大脑器质性病变, 即由于大脑萎缩、老化、大脑细胞受挫等引起的智能障碍性疾病, 是目前世界范围内医护难题。护理和医疗在延缓老年痴呆症患者病情进展, 维持认知能力、活动能力, 改善患者生活质量中发挥重要作用, 护理和医疗在其中密不可分。因此只有医护人员密切协作, 共同商讨、制定患者诊疗和护理方案, 才能确保全方位、连续性、科学性地护理患者, 满足患者各方面需求, 使医疗和护理水平提高^[6]。医护一体化模式是医护人员共同参与的护理活动, 从患者需求出发, 采用医护人员协作方法, 有合理分工、密切联系、信息交换、相互协作、补充促进, 调动患者家属积极性, 达到预防不良事件, 提高患者生活质量的目的^[7-8]。

医护一体化模式的优势分析: (1) 医护一体化模式优化了查房制度: 对照组采用的是传统查房, 由护士、医生各自进行; 观察组使用的医护一体护理模式将医生和护士作为一个小组, 同时进行查房, 打破医、护两条线的查房模式。这种医护协调小组护理模式应用在临床护理中, 使以往“医生说护士做”的指导与配合关系发生转变, 有利于激发护士学习医疗理论和操作的兴趣, 调动起工作积极性, 同时加强医护人员合作意识, 建立团队精神。(2) 医护一体化模式使护理方案更全面并具有针对性: 以往笔者所在医院采用的护理方式缺乏针对性, 无法提高患者的护理满意度; 而医护

一体化模式将风险评估和 ADL 评估灵活用于护理中, 评估患者对护理的依赖程度, 重点对智能和活动能力较差的患者给予生活帮助和监督。因此提高了工作效率和护理准确性、全面性, 得到患者家属高度评价。观察组患者家属护理总满意度(92.0%)较对照组(76.0%)高, 差异具有统计学意义($P < 0.05$)。(3) 医护一体化加强了风险管理: 老年痴呆症患者身体各项功能逐渐退化, 因此安全隐患较多, 对护理质量要求更高。确保护理安全性是老年痴呆症护理中的基本要求, 同时是避免事故和医疗纠纷的基本保证。观察组根据所在医院多年实际情况, 将噎食、压疮、跌倒归为所在科室发生最频繁的三大不良事件, 并组织医护人员共同商讨一套评估方案, 按患者个体风险程度不同, 制定防范措施, 有效减少不良事件发生; 观察组不良事件发生率(4.00%)较对照组(18.00%)低, 差异具有统计学意义($P < 0.05$)。(4) 医护一体化模式的其他优势: 医生与护士之间可靠合作来提高护士的护理效率, 同时在心理护理的基础上增加人文关怀, 为患者营造温馨的治疗环境, 既能调节患者情绪, 又能有效缓解认知功能退化。观察组患者 ADL 得分低于对照组, MMSE 及认知功能各项得分均高于对照组, 差异具有统计学意义($P < 0.05$)。

医护一体化模式的问题及解决方式: 医护一体化模式开始实施的过程中仍出现部分问题, 这种护理模式对于护理人员的数量以及结构具有较高的要求, 导致医院的护理人员相对不足; 该模式实施后, 容易引起护理责任小组之间的竞争, 造成患者收治不均; 该模式对于护士的工作要求更高, 包括大量护理项目, 很多项目需多人配合才可以完成; 护理工作统计数量多、难度大, 且护理人员的绩效考核需进一步优化。而上述问题我科室通过人力资源部的合理安排、着力解决护理人员不足的问题, 制定相关的奖惩制度, 完善患者的收治分管管理改善患者收治不均的问题, 制定严格的护理人员培训考核制度, 不断提高护士的积极性, 达到稳定团队的目的。

综上, 医护一体化模式能显著提高老年痴呆症住院患者护理质量, 有利于维持其认知功能、活动功能, 延缓疾病发展, 减少不良事件, 得到患者家属高度认可。

利益冲突 文章所有作者共同认可文章无相关利益冲突

作者贡献声明 葛兆霞: 构思与设计; 周荣梅: 研究实施、数据收集、文献调研与整理、数据分析与解释、论文撰写; 葛兆霞、张智: 审校

· 研究荟萃 ·

产褥期妇女盆底肌功能锻炼知信行及需求现状调查

张明娜 肖倩 吴瑛

100069 北京,首都医科大学护理学院

通信作者:吴瑛, Email: helenywu@vip.163.com

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2017.30.011

【摘要】目的 了解产褥期妇女盆底肌功能锻炼知信行及需求现状,为临床开展产后盆底康复宣教及治疗提供依据。**方法** 采用自制的产褥期妇女盆底肌功能锻炼知信行及需求调查问卷,对 150 名 2017 年 4—6 月在北京某三甲医院妇产科门诊进行产后 42 d 复查的产妇进行问卷调查。**结果** 产后漏尿的发生率为 14.7%,不同分娩方式产妇在产后发生盆底功能障碍性疾病的差异有统计学意义($P < 0.05$);不同产次产妇在产后发生盆底功能障碍性疾病的差异无统计学意义($P > 0.05$)。产褥期妇女盆底肌功能锻炼知信行总分为 (66.6 ± 11.97) 分,处于中等水平;不同基本资料、孕期产后情况产妇,盆底肌功能锻炼认知、态度、行为评分差异有统计学意义($P < 0.05$),但总分差异无统计学意义($P > 0.05$)。83.3%的产妇希望了解盆底功能锻炼的相关知识;72.0%的产妇倾向动画视频形式的宣教形式。**结论** 产妇盆底肌功能锻炼知信行水平亟待加强,建立和完善产后盆底肌功能康复宣教体系势在必行。

【关键词】 产褥期; 盆底功能障碍; 盆底肌功能锻炼; 知信行**基金项目:**首都护理学研究专项面上课题(16HL17)

参 考 文 献

- [1] 李华,慕琰萍,常亭玲,等.住院老年痴呆患者护理不良事件现状及影响因素分析[J].中国实用护理杂志,2013,29(23):28-31. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2013.23.012.
- [2] 张玉红.以行动研究法为基础的进食护理在老年痴呆患者中的应用[J].中国实用神经疾病杂志,2016,19(4):129-130. DOI: 10.3969/j.issn.1673-5110.2016.04.081.
- [3] 胡竹芳,吴慧群,邓兵翻.情感护理法对中度老年痴呆患者精神状态及生活能力的影响[J].国际护理学杂志,2014,11(5):1152-1154. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4351.2014.05.087.
- [4] 寇洁,陈文静.医护一体化模式在PCI术后患者中应用的效果评价[J].中国实用护理杂志,2014,30(4):29-31. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2014.04.009.
- [5] 张军花,钟奕.医护一体化模式在手术部位标识管理中的应用效果[J].中华现代护理杂志,2016,22(7):1021-1023. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2016.07.037.
- [6] 郑欣,尤振兵,田文泽,等.医护一体化护理对食管癌患者焦虑抑郁负面情绪及免疫功能的影响[J].中国实用护理杂志,2015,12(26):1994-1998. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2015.26.014.
- [7] 张健,邢燕,徐静静,等.医护一体化为中心的优质护理服务模式在放疗科的应用[J].中华现代护理杂志,2013,19(23):2829-2831. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2013.23.032.
- [8] 李欢,宁宁,马莉,等.护理人员对实施医护一体化工作模式的评价[J].护理研究,2012,26(32):3040-3041. DOI: 10.3969/j.issn.1009-6493.2012.32.037.

(收稿日期:2017-01-11)

(本文编辑:何成伟)